ZGŁOSZENIE SZKODY I ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE ORAZ ZADOŚĆUCZYNIENIE

....., dnia ..... r.
(miejscowość, data)

Poszkodowany / Poszkodowana:

Imię i nazwisko: .....
Adres zamieszkania: .....
PESEL (lub seria i nr paszportu w przypadku braku PESEL): .....
Nr telefonu: .....
Adres e-mail: .....
Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczeń: .....

Adresat (wybierz właściwy wariant i skreśl pozostały):

Wariant A — ubezpieczyciel OC: Zakład ubezpieczeń, w którym podmiot/lekarz był ubezpieczony w dacie świadczenia. W tym wariancie poszkodowany może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela na podstawie art. 822 § 4 KC (*actio directa*). **Wariant B — podmiot leczniczy lub lekarz:** podmiot, którego odpowiedzialność cywilna ma zostać ustalona. W tym wariancie pismo jest zgłoszeniem roszczenia temu podmiotowi, a art. 822 § 4 KC nie jest podstawą roszczenia bezpośrednio wobec adresata. .....
(Nazwa Zakładu Ubezpieczeń S.A. / Towarzystwa Ubezpieczeń lub Podmiotu Leczniczego)
.....
(Adres centrali / Departamentu Likwidacji Szkód lub adres podmiotu leczniczego)

Dotyczy: zgłoszenia szkody na osobie i roszczeń związanych ze świadczeniem zdrowotnym udzielonym w dniu ..... r.

Podmiot/lekarz, którego dotyczy zgłoszenie: Nazwa podmiotu leczniczego / Lekarz: .....
Adres placówki: .....
Seria i numer polisy OC: .....
Numer szkody (jeśli został już nadany): .....

ZGŁOSZENIE SZKODY I ROSZCZEŃ

Działając we własnym imieniu, zgłaszam szkodę i przedstawiam roszczenia opisane poniżej. Jeżeli adresatem jest ubezpieczyciel, podstawą roszczenia bezpośredniego jest art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego oraz — w zakresie obowiązkowego OC — ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Jeżeli adresatem jest podmiot leczniczy lub lekarz, podstawą żądania jest przypisywana temu adresatowi odpowiedzialność cywilna, wymagająca ustalenia w okolicznościach sprawy.

1. **ZGŁASZAM SZKODĘ NA OSOBIE ORAZ SZKODĘ MAJĄTKOWĄ** i wnoszę o zbadanie, czy podczas udzielania świadczenia opisanego poniżej doszło do działania lub zaniechania niezgodnego z wymaganą starannością, czy spowodowało ono szkodę oraz jaki jest związek między tym zdarzeniem a zgłoszonymi następstwami. W przypadku gdy odpowiedzialność i wysokość roszczenia są już poparte dowodami, można opisać ustalenia wprost, wskazując te dowody;
2. **WNOSZĘ O WYPŁATĘ** następujących kwot na wskazany rachunek, w terminach wynikających z właściwych przepisów: - **a) kwoty ..... zł** *(słownie: .....)* tytułem **odszkodowania — wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia naprawczego** (art. 444 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego) zgodnie z załączonym planem leczenia i kosztorysem z dnia ..... r., z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do żądania zwrotu dalszych kosztów leczenia powikłań; - **b) kwoty ..... zł** *(słownie: .....)* tytułem **zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne** (art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego); - **c) kwoty ..... zł** *(słownie: .....)* tytułem **odszkodowania za poniesione dotychczas koszty leczenia, badań diagnostycznych, leków i dojazdów** (art. 444 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego) — zgodnie z załączonymi rachunkami i fakturami.

Jeżeli pismo jest kierowane do ubezpieczyciela, art. 819 § 4 KC przewiduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przez zgłoszenie roszczenia lub zdarzenia objętego ubezpieczeniem; bieg rozpoczyna się na nowo po otrzymaniu pisemnego oświadczenia ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Nie należy zakładać, że zgłoszenie ubezpieczycielowi przerywa przedawnienie roszczeń wobec innych podmiotów.

I. STAN FAKTYCZNY I CHRONOLOGIA ZDARZEŃ

0. **Historia wcześniejszego leczenia (wypełnić w wariancie nawrotu / kontroli po zabiegu; w wariancie pierwotnego przeoczenia pominąć):** Wcześniej w placówce wykonano: ..... *(np. resekcja wierzchołków korzeni zębów nr ..... i wyłuszczenie torbieli w dniu ..... r.)*. Według posiadanych dokumentów / informacji przekazanej pacjentowi, kontrola z dnia ..... r. wykazała: ..... . Dołączyć opis lub wskazać, jeśli relacjonowana informacja była ustna.

1. **Wizyta sporna — data zarzutu (dzień ..... r.):** Odbyłem/am wizytę w placówce ..... . Wykonano / oceniano badanie CBCT okolicy ..... . Przekazano mi: ..... *(wskazać, czy ustnie czy na piśmie i kto przekazał informację)*. Zalecono: ..... . Według mojej wiedzy nie zalecono wówczas: ..... . Wpis, opis i pliki badania: ..... *(załączam / oczekuję na wydanie / nie posiadam)*. *W wariancie nawrotu opisz wcześniejsze leczenie i kontrolę jako tło. Nie stwierdzaj, że nawrót był widoczny w badaniu spornym, dopóki nie potwierdzi tego porównanie badań lub inny wiarygodny dowód.*

2. **Wystąpienie powikłań (okres ..... r.):** W okresie ..... wystąpiły następujące objawy: ..... . Odnotowano je w dokumentacji / zdjęciach / innych dowodach: ..... . Wymienić tylko objawy rzeczywiście występujące i wskazać ich źródło. *Opisać zgodnie z prawdą ewentualne wcześniejsze objawy i przerwy w konsultacji. Ich prawne znaczenie zależy od związku z powstaniem lub zwiększeniem szkody; samo ich wystąpienie nie przesądza automatycznie o przyczynieniu.*

3. **Kolejna wizyta i rozpoznanie zmiany (dzień ..... r.):** Dnia ..... r. zgłosiłem/am się do ..... . W badaniu stwierdzono / przekazano mi: ..... . Wykonano: ..... . W dokumentacji wpisano: ..... . Jeżeli uzyskano porównawczą ocenę wcześniejszego CBCT, streścić jej wnioski i dołączyć dokument: ..... . Jeżeli takiej oceny nie ma, napisać to wprost i nie przypisywać lekarzowi wniosków, których nie wydał. Następstwa, których dotyczy roszczenie: ..... . Związek tych następstw z opóźnionym rozpoznaniem uzasadniam następującymi dowodami: ..... . Plan i koszt leczenia: ..... . Kwota obejmuje: ..... .

II. PODSTAWA PRAWNA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. **Art. 415 Kodeksu cywilnego:** może stanowić podstawę odpowiedzialności osoby, której zawinione działanie lub zaniechanie spowodowało szkodę. W ocenie postępowania lekarza znaczenie ma art. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz wymaganie należytej staranności. Czy w konkretnym przypadku doszło do naruszenia standardu, wymaga oceny dowodów i okoliczności medycznych.
2. **Art. 430 Kodeksu cywilnego:** może mieć zastosowanie do podmiotu, który powierzył czynności osobie podlegającej jego kierownictwu i obowiązanej stosować się do wskazówek. Nie zakładać automatycznie odpowiedzialności placówki wyłącznie dlatego, że świadczenia udzielono w jej gabinecie; ustalić formę praktyki i relację z lekarzem.
3. **Art. 444 § 1 i art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego:** Naprawienie szkody na osobie obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty. Na żądanie poszkodowanego podmiot zobowiązany jest wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Nadto poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę niemajątkową (ból,

zniekształcenie twarzy, cierpienie, stres, utrudnienia w życiu codziennym).

4. **Art. 822 § 1 i § 4 Kodeksu cywilnego:** Ubezpieczyciel przez umowę ubezpieczenia OC przejmuje odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone osobom trzecim, a poszkodowany uprawniony jest do dochodzenia roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.
5. **Art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:** Podstawowy termin wypłaty wynosi 30 dni od zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli wyjaśnienie odpowiedzialności lub wysokości świadczenia nie jest w tym czasie możliwe, ustawa przewiduje dalszy termin liczony od chwili, gdy wyjaśnienie stało się możliwe, co do zasady nie później niż 90 dni od zgłoszenia, z ustawowymi wyjątkami. W terminie podstawowym należy wypłacić część bezsporną. Nie oznacza to gwarancji wypłaty całej żądanej kwoty w 30 dni.

III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Kopia dokumentacji medycznej z placówki ubezpieczonego (karty wizyt, historia leczenia);
2. Płyta CD / pendrive / nośnik z cyfrowym zapisem badania CBCT z dnia ..... r. (format DICOM) wraz z opisem radiologicznym;
3. Pisemna ocena lekarza dotycząca badania lub porównania CBCT z dnia ..... r. — jeżeli została uzyskana;
4. Plan leczenia naprawczego wraz ze szczegółowym kosztorysem procedur z dnia ..... r.;
5. Dokumentacja fotograficzna obrzęku twarzy i widocznych powikłań (z oznaczeniem dat);
6. Kopie imiennych faktur i rachunków potwierdzających dotychczas poniesione koszty leczenia, badań, leków i dojazdów;
7. Dziennik dolegliwości bólowych, gorączki, bezsenności i wykaz przyjmowanych leków;
8. Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, tzw. L4) wynikające z powikłań (opcjonalnie);
9. Kopia uprzednio złożonego wniosku o udostępnienie dokumentacji i wskazanie polisy OC wraz z potwierdzeniem odbioru.

Dołączaj tylko dokumenty, które istnieją i dotyczą tej sprawy; usuń pozycje, których nie możesz potwierdzić. W razie trudności z oceną roszczenia lub sporu co do odpowiedzialności można skorzystać z pomocy właściwego rzecznika lub profesjonalnego pełnomocnika (adwokata / radcy prawnego).

IV. POUCZENIE I DALSZE KROKI

W przypadku bezczynności, odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia kwoty świadczeń, zastrzegam sobie prawo do: 1. Skierowania wniosku o postępowanie interwencyjne do Rzecznika Finansowego; 2.

Złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy właściwej Okręgowej Izbie Lekarskiej; 3. Wytoczenia powództwa cywilnego przed sąd powszechny wraz z żądaniem ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wymagalności roszczenia.

Z poważaniem,

.....

(własnoręczny podpis Poszkodowanego / Poszkodowanej)